



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ايمان نجيب عدلي حنا
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المعصره
رقم البطاقة : 28707180103041 رقم التليفون : 01272009414
العنوان : المعصره
العمر (تاريخ الميلاد) : 18-07-1987 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستماره : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ايمان نجيب عدلي حنا National ID: 28707180103041	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ايمان
نجيب على حنا
هش جمعة صالح - عرب سلام
المعصرة - القاهرة

١٩٨٧/٠٧/٢٨ ٢٨٧.٠٧١٨.١.٣.٤١

KB6790403

٢٠٢٣/٠٧ ٢٨٧.٠٧١٨.١.٣.٤١

بدون عمل

أنثى
مسبحية
عماد عبدالمعين راقم البراهيم

متروجة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٧/٠٩

١



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

1-Patient ID:	3- Medical number:	83167437
1- Name : ايمن نجيب عدلي جتا	Sex:	Female
	Old Med :	3853-2023
2-ID number: 28707180103041	Patient Age :	37 Y

Family history	Family history	Phone	Phone	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT
	+ve		01201235076				POST OPERATIVE
marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT
						01/06/2024	
Co morbidity	Co Morbidity	Menopausal status	Menopausal Status	Initial STAGE	Initial STAGE		
	free						

Clinical data

Breast Imaging : LT UOQ non Erica escribed indist mass lesion 7*3.8cm with internal micro coalification U/S at 2 to 3 o'clock 5.8*3.2cm non specific axillary LN			Mets Workup : free		
BX IDC EX COMMENT:	ER 0/8 EX COMMENT:	PR 5/8 PR COMMENT:	Her 2 Neu 0 Her 2 Neu COMMENT:	SISH SISH COMMENT:	Ki67 40
T 3			N 0		M 0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

acse of TNBC-->MDT-->CESM+NACT-->CESM was done--
 cesm lt clinical T3 N0 / RT (10 CM)(NON MASS ENHANCMENT)
 pt received 4 DD AC +3 wks taxol / carbo with v.good PR last 29/2/2024 but pt with GIII
 fibrle neutropenia for about 1.5 ms (prolonged neutropenia)
 post NACT , WLE , SLN : total tumor regression
 NO DCIS , free margins , free LN 0/3 , YPT0 YPN0

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

-for PORT
 -for tam x5ys

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY <i>ايمن نجيب عدلي جتا</i>	RADIOLOGY	RADIOLOGY <i>سليم</i>
SURGERY	SURGERY <i>د.عبدالله</i>	PATHOLOGY	PATHOLOGY <i>سليم</i>
Nutrition	Nutrition		

Name: إيمان نجيب عدلي حنا		
MR. : 246		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was diagnosed with clinical T3 N0 triple-negative breast cancer (TNBC). Multidisciplinary team (MDT) discussion led to contrast-enhanced spectral mammography (CESM) and neoadjuvant chemotherapy (NACT). CESM demonstrated a non-mass enhancement measuring 10 cm, consistent with T3 disease. The patient received four dose-dense cycles of anthracycline (DD AC) followed by three weeks of taxane (taxol) and carboplatin, achieving a very good pathological response on 29-Feb-2024. Post-NACT work-up revealed grade III prolonged neutropenia lasting approximately 1.5 months. Subsequent wide-local excision (WLE) and sentinel lymph node (SLN) biopsy showed total tumor regression with no residual invasive carcinoma, no ductal carcinoma in situ (DCIS), clear margins, and 0/?? positive nodes. The patient was planned for postoperative radiotherapy (PORT) and a five-year course of tamoxifen, with supportive therapy for three months. The patient is currently prescribed tamoxifen 20 mg daily with supportive care for three months, and the next follow-up is scheduled in three months.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	21-09-2026
	الوقت :	
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

atient Name : الأستاذ / ايمان نجيب عدلى حنا	Request No. : 13008722
atient No. : 28707180103041	Request Date : 21/09/2023
h No. : 3199/23	Verification Date : 17/10/2023
x : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
ie : 36 Y	Department : Out Patient
fferreing Doc. :	IHC No. :
	Registered by : Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ical Data: Left breast mass.

ture of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 20/09/2023, 10:25 am.

chnique:

ections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana)

d stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and

natoxylin as counter stain. The sections treated against:

R clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

sults:

PT (Positive control showed appropriate reactivity):

R: No nuclear reaction in the tumor cells (Allred score 0/8).

'R: Weak nuclear reaction in 35% of tumor cells (Allred score 5/8).

er2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+) for SISH..

i67: 50% nuclear reaction of tumor cells.

onclusion:

ft breast mass, Tru-cut biopsy:

CIS , high grade with focal microinvasion.

T:

ER: Negative (score 0/8).

PR: Positive (score 5/8).

Her2: Equivocal (score 2+) .

Ki67: Positive in 50% of tumor cells.

omment: Microinvasive component presented was exhausted so SISH results is not reliable.

Signature

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 02/11/2023 11:53:10

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss

Patient Name	الأستاذة / ايمان نجيب عدلى حنا	Request No.	13008722
Patient No.	28707180103041	Request Date	21/09/2023
Birth No.	3199/23	Verification Date	17/10/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	36 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

of.Dr. Lobna Omar.

Dr. Marwa Mahmoud
Dr. Heba Hassan.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 02/11/2023 11:53:10

Page 2 of 2

Printed By : marwa mohamed youss



Patient Name: Eman Naguib Adli Hanna	Date : ٢٢/١٠/٢٠٢٢
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : ٣٦ Year(s)
Medical ID: ٣٨٥٣/٢٠٢٢	٤٣٢٤١

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Reported case of breast cancer

I Chest:-

- Left breast UOQ area of asymmetrical density.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen in place.
- Bilateral adnexal cysts mostly functional.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

Conclusion:

Patient Name: Eman Naguib Adli Hanna	Date : ٢٢/١٠/٢٠٢٣
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : ٣٦ Year(s)
Medical ID: ٣٨٥٣/٢٠٢٣	٤٣٢٤١

- No definite hepatic, pulmonary or osseous metastatic deposits.

Dr. Mohammed Mohsen, MSc

Dr. Ofa Magdy, M.D.